

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003502-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SIMONE DA SILVA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO DE PARTE AUTORA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFIGURADA A URGÊNCIA NO QUADRO CLÍNICO, JÁ QUE A PARTE AUTORA FOI INSERIDA EM FILA EM 04/12/2024 E ATÉ AGORA NÃO HOUE A AVALIAÇÃO NECESSÁRIA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TRATAMENTO JÁ INICIADO, NO ENTANTO, A DEMORA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PARA ADJUVÂNCIA PODE INVALIDAR TODO O TRATAMENTO JÁ REALIZADO ATÉ O MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a tutela de urgência deferida na decisão do evento 10. Publique-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, baixe-se e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5003502-13.2025.4.02.5101

510015514228 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5003502-13.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: SIMONE DA SILVA COSTA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos. Vejamos:

"Para o deferimento da tutela jurisdicional liminar, impõe-se a demonstração, de plano, de alta probabilidade quanto ao direito pretendido e, ainda, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC), ou do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, por parte do réu (art. 311, I, do CPC).

A questão em apreço deve ser analisada à luz do disposto no art. 196 da Carta Magna, que outorga verdadeiro direito subjetivo aos que necessitem dos serviços públicos de assistência à saúde, incumbindo ao Poder Público a tarefa de concretizá-lo (RE-271286/RS, Relator Min. Celso de Mello, DJ 23/08/2000).

Da mesma forma, o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990.

Trata-se, portanto, de direito fundamental, consectário lógico do princípio da dignidade da pessoa humana e indissociável do direito à vida. Admite-se, pois, que o titular de tal direito possa postular, por meio da via judicial, prestação positiva do Estado que imprima ao comando constitucional eficácia plena.

Por outro lado, não se pode olvidar de que o próprio art. 196 em comento estabelece a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços direcionados à promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nesse diapasão, impende observar a “reserva do possível”, sob pena de ocasionar indesejáveis situações anti-isonômicas.

Com efeito, “o direito à saúde, positivado no art. 196 da Constituição, não significa acesso irrestrito a todo tipo de assistência médico-hospitalar, segundo a conveniência de cada paciente, cujas pretensões singulares ou atípicas, se atendidas sem juízo de ponderação e indiscriminadamente, podem comprometer a governança das redes públicas de saúde, vulnerando o ideal republicano da igualdade de todos perante a lei. Para não afetar o princípio da separação dos poderes, o Poder Judiciário só pode intervir nos critérios do SUS para afastar ilegalidades, sendo insuficientes a tal desiderato a mera exibição de laudos médicos, particulares ou oficiais, visto que na saúde pública os tratamentos sujeitam-se a múltiplos fatores, a saber: indisponibilidade momentânea do tratamento ou falta de leitos hospitalares; carência de recursos orçamentários; limitações terapêuticas e de ofertas de remédios; insuficiência de médicos, enfermeiros e auxiliares; a fase evolutiva de medicamentos até a sua aprovação definitiva pelos órgãos competentes” (TRF2, Sexta Turma Especializada, AG - Agravo de Instrumento - 233160, Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, DJe 06/02/2014).

Vale dizer que, não obstante a urgência de cada caso concreto, não se pode perder de vista a possibilidade de haver outras urgências ainda maiores aguardando o mesmo tipo de tratamento. Sob esse prisma, a eventual imposição do fornecimento aleatório e indiscriminado de certo tratamento tem o potencial de inviabilizar o próprio sistema de saúde pública.

Por isso, cumpre analisar as peculiaridades de cada caso concreto, partindo-se da premissa de que, via de regra, os médicos do SUS dão atendimento às patologias verificadas. De conseguinte, a intervenção judicial deve-se limitar a hipóteses de negativa injustificada, sob pena de o Estado ver rompida com toda a sua política de saúde.

De seu turno, a Lei nº 12.732/12 - que dispõe acerca do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) - estabelece que “o paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei” (art. 1º).

Prevê, ainda, que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único” (art. 2º), e considera que “para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso” (art. 2º, §1º).

A mesma norma ainda prevê, em seu artigo 2º, §3º, que “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.”

Da mesma forma, a Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde, que regula a aplicação da Lei nº 12.732/12, prevê que:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com:

I - a realização de terapia cirúrgica;

II - o início de radioterapia; ou

III - o início de quimioterapia.

Parágrafo único. Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas nos incisos I a III do “caput” terão acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde.

Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente.

§ 1º O prazo previsto no “caput” poderá ser reduzido por profissional médico responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no “caput” aos seguintes casos de neoplasia maligna:

I - câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular;

II - câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; e

III - casos sem indicação de tratamento descritos no art. 2º.

Correlatamente, o art. 2º, §2º, Lei nº 12.732/12, estabelece que “os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos” e, por fim, o art. 5º da Portaria nº 876/13 do Ministério da Saúde dispõe que “cabe aos serviços de saúde dos diferentes níveis de atenção observar o fluxo disposto no art. 4º e prestar assistência adequada e oportuna aos usuários com diagnóstico comprovado de neoplasia maligna de acordo com as responsabilidades descritas na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer”.

Portanto, o prazo de 60 (sessenta) dias definido na lei para atendimento inicial deve ser estendido às etapas subsequentes de atendimento e assistência, se necessárias.

No caso concreto, há constatação de que a autora realizou exame histopatológico em 21/10/2024, constatando a existência de metástases para linfonodos (Evento 1, ANEXO2, fl. 9). O diagnóstico da autora a respeito da neoplasia foi confirmado pelos demais laudos apresentados nos autos (Evento 1, ANEXO2, fl. 6, 8 e 10).

Cumprido, desde logo, destacar que, apesar da alegação de urgência do pleito autoral, não há nos autos prova de que seu quadro clínico seja expressivamente mais urgente do que naturalmente já o são aqueles decorrentes de diagnósticos de neoplasia, a justificar sua priorização em face dos demais paciente oncológicos que aguardam atendimento.

O laudo apresentado no Evento 1, ANEXO2, fl. 6, que afirma “indicação absoluta de realizar quimioterapia adjuvante em um prazo máximo de 03 meses a contar da data da cirurgia”, coaduna-se com as normas incidentes no caso concreto, que também estabelecem o mesmo prazo para o início efetivo do tratamento.

Com efeito, de acordo com as informações prestadas pelos órgãos de regulação no Evento 2, a autora foi inserida no SER apenas no dia 04/12/2024, mas sua solicitação ainda não foi atendida. Todavia, não transcorreu o lapso temporal estabelecido pela lei para início de atendimento, o que obsta, por ora, o deferimento da medida de urgência pretendida.

*Isto posto, **INDEFIRO, por ora, A TUTELA DE URGÊNCIA.***

Alega a parte recorrente que necessita, com urgência, de consulta com médico oncologista, já que foi diagnosticada com neoplasia maligna, conforme exame anátomo patológico com resultado em 21/11/2024.

Observando que nos autos originários não havia determinação de intimação do NAT para apresentar parecer, a fim de verificar a necessidade e urgência do pleiteado, em observância ao enunciado 18 do CNJ (III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019), foi determinada a intimação do NAT, que apresentou parecer no evento 7.

Na decisão do evento 10 foi deferida a tutela de urgência para que os réus, dentro de suas esferas de competência, agendem consulta ambulatorio 1ª vez - coloproctologia (oncologia) no prazo máximo de 10 dias.

VOTO

Tendo em vista que não houve alteração no quadro fático, mantenho o decidido no evento 10, cujo fundamento passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

O parecer do NAT informa o seguinte:

“Trata-se de Autora, de 53 anos de idade, que foi submetida à retossigmoidectomia a Hartmann, no dia 14 de novembro de 2024, no Hospital Municipal Salgado Filho, devido a diagnóstico de neoplasia maligna de sigmoide associada a obstrução intestinal. O resultado do exame anatomopatológico revelou adenocarcinoma com metástase linfonodal (estadiamento T4aN2 M0) com indicação absoluta de realizar quimioterapia adjuvante, em um prazo máximo de 3 meses, a contar da data da cirurgia. Em caso de não realizar a quimioterapia, há chance de recidiva do câncer e risco de morte. Encontra-se aguardando, via Sistema Estadual de Regulação - SER, consulta com oncologia clínica para iniciar sessões de quimioterapia (Evento 1, ANEXO2, Página 6 do processo originário). Foram pleiteados consulta em oncologia e tratamento oncológico (Evento 1, INIC1, Página 8).”

Ainda de acordo com o NAT, a consulta em oncologia e o tratamento oncológico pleiteados estão indicados ao manejo do quadro clínico apresentado pela Autora, e estão cobertos pelo SUS.

Por fim, informou que, em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II), verificou-se que a parte autora foi inserida em 04 de dezembro de 2024 para ambulatorio 1ª vez - coloproctologia (oncologia) **com classificação de risco vermelho** e situação em fila, sob a responsabilidade da central REUNI-RJ, ocupando a posição nº 533.

Pois bem.

AJCC (2018) : pT4a; pN2b.

LAUDO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRM: 68540-2
Nome: MAURICIO DE FIGUEIREDO NOCCHI
Endereço: RUA DR. CELESTINO, 122 IOFFICES - SALA 1201 - CENTRO, NITEROI, CEP: 24020091
Telefone: (21) 3111-4309

Paciente: Simone da Silva Costa

Descrição:

Declaro para os devidos fins que a Senhora Simone da Silva Costa foi submetida à retossigmoidectomia a hartmann no dia 14 de novembro de 2024 no Hospital Salgado Filho por neoplasia maligna de sigmoide associado à obstrução intestinal.

O resultado do exame anátomo patológico revelou adenocarcinoma com metástase linfonodal.

Estadiamento T4aN2 M0.

Com indicação absoluta de realizar quimioterapia adjuvante em um prazo máximo de 3 meses a contar da data da cirurgia.

Pois caso não for feita aumenta a chance de recidiva do câncer de forma substancial e levando a risco de morte para a paciente.

Solicito que seja marcado o quanto antes a consulta com a oncologia clínica para iniciar a sessões de quimioterapia.

Atenciosamente,

Ressalta-se que, o tratamento adjuvante é aquele que se inicia após uma intervenção considerada principal para a retirada do tumor, e é feito com o objetivo de destruir as células cancerígenas que possam ainda estar presentes no organismo após essa intervenção. Assim, a avaliação é necessária, sob pena de ineficácia do procedimento já realizado pela autora. Observa-se que a mesma foi inserida em fila com risco vermelho de urgência, de acordo com o informado pelo NAT.

De acordo com os elementos constantes nos autos, entendo restar configurada a urgência no quadro clínico, já que a parte autora foi encaminhada para consulta há quase 3 meses (inserida em fila em 04/12/2024) e até agora não houve a avaliação necessária a continuidade do tratamento.

Ressalta-se que já houve início do tratamento, no entanto, entendo que a demora na realização de avaliação para adjuvância pode invalidar todo o tratamento já realizado até o momento.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a tutela de urgência deferida na decisão do evento 10. Publique-se. Intime-se. Após o decurso de prazo, baixe-se e archive-se.